Resumos de Pediatria

Batistaz

Caderno de Estudos · Emergência

Choque e Sepse na Criança

Da suspeita à primeira hora

Internato de Pediatria

10º período · 2026.2

Sumário

Choque e sepse na criança · da suspeita à primeira hora

I Esta criança está em choque? 3
Perfusão, sinais de alerta e o semáforo da criança febril

II Que tipo de choque é? 4
Hipovolêmico, distributivo, cardiogênico, obstrutivo

III É sepse? O escore de Phoenix 5
Definição de 2024 e o que mudou

IV O que fazer na primeira hora? 6
Lactato, culturas, antibiótico, fluido, vasoativo, foco

V Quanto fluido e qual? 7
Bolus, soro balanceado, sobrecarga, manutenção isotônica

VI Quando entra o vasoativo? 8
Adrenalina, noradrenalina, acesso periférico, corticoide, oxigênio

VII Qual antibiótico e qual foco? 9
Cobertura empírica, pré-referência, descalonamento

VIII E se for anafilaxia? 10
Critérios, adrenalina IM, observação e alta

IX Mapa de decisão e pegadinhas 11

X Questões de estudo 12

— Gabarito, fontes e anotações 13

Como ler este caderno

Cai na prova
O que costuma ser cobrado ou confundido.

Conduta
O que fazer no plantão, em ordem.

Atenção
Armadilha clínica ou divergência entre diretrizes.

As chaves entre colchetes indicam a fonte de cada dado: [SSC] Surviving Sepsis Campaign pediátrica (2026), [PHX] SBP, critérios de Phoenix (2024), [SBP-S] SBP sobre a SSC 2020, [ANAF] SBP anafilaxia (2021), [AIDPI], [NICE-F] NG143 e [NICE-L] NG29. Lista no fim.

Capítulo I

Esta criança está em choque?

*Choque é perfusão inadequada. Na criança, a **hipotensão é tardia**: não se espera por ela para tratar a má perfusão [SSC].*

O que olhar, junto e repetidas vezes

Frequência cardíaca, pressão arterial, **enchimento capilar**, temperatura das extremidades, qualidade dos pulsos, nível de consciência e diurese [SSC]. Medir a PA quando FC ou enchimento capilar estão alterados [NICE-F].

Tabela 1 · *Semáforo da criança febril (menor de 5 anos)*

	Amarelo (risco intermediário)	Vermelho (risco alto)
Cor	Palidez relatada pelos pais	Palidez, pele moteada, cinzenta ou cianótica
Atividade	Pouca resposta; só acorda com estímulo prolongado; sem sorriso	Aspecto muito doente; não acorda ou não se mantém acordada; choro fraco, agudo ou contínuo
Respiração	Batimento de asa; FR > 50 (6–12 m) ou > 40 (> 12 m); SatO2 ≤ 95%	Gemência; FR > 60; tiragem moderada a grave
Circulação	Taquicardia (> 160 se < 12 m; > 150 de 12–24 m; > 140 de 2–5 a); enchimento capilar ≥ 3 s; mucosas secas; pouca diurese	Turgor diminuído
Outros	Febre ≥ 39 °C de 3 a 6 meses; febre ≥ 5 dias (pensar em Kawasaki)	Menor de 3 meses com ≥ 38 °C; **exantema que não desaparece à pressão**; sinais meníngeos ou focais

[NICE-F]. Resposta ao antitérmico não separa doença grave de doença leve.

Atenção · cortes que não se trocam

Enchimento capilar: **> 2 s** é sinal de perigo no AIDPI; ≥ 3 s é amarelo no semáforo do NICE [AIDPI] [NICE-F]. Febre e taquicardia isoladas não fazem diagnóstico de sepse; servem para reconhecer a criança que precisa de avaliação já [SBP-F] [NICE-F].

Conduta · criança febril com choque

- Oxigênio (choque ou SatO2 < 92%), acesso venoso ou intraósseo, monitor [NICE-F].
- **Bolus** de cristaloide (10 mL/kg, reavaliando) se **choque**; **antibiótico parenteral imediato** se choque, criança que não acorda ou sinais de doença meningocócica [NICE-F] [SSC].
- Avaliação por pediatra experiente e considerar UTI [NICE-F].

Capítulo II

Que tipo de choque é?

*Na criança, os mais comuns são o **hipovolêmico** (perdas) e o **séptico**. O tipo muda quanto fluido dar e qual droga escolher.*

Tabela 2 · *Pistas para o mecanismo*

Tipo	Pistas e cuidado
Hipovolêmico	Diarreia, vômitos, queimadura, sangramento. Desidratação grave no AIDPI: 2 sinais entre letargia ou inconsciência, olhos fundos, não consegue beber ou bebe muito mal e sinal da prega que volta muito lentamente. Plano C: caderno de diarreia [AIDPI]
***Séptico** (distributivo)*	Infecção suspeita + má perfusão; pode haver vasodilatação (extremidades quentes) ou baixo débito (frias). O perfil hemodinâmico varia de criança para criança [SSC]
***Anafilático** (distributivo)*	Exposição a alérgeno + pele, respiração ou circulação; a pele pode estar normal. Tratamento: adrenalina IM (capítulo VIII) [ANAF]
Cardiogênico	Congestão (hepatomegalia, crepitações) que piora com volume. A disfunção miocárdica também aparece na sepse; o ultrassom à beira do leito ajuda a separar [SSC]. Volumes menores na cardiopatia [NICE-L]
Obstrutivo	Pneumotórax hipertensivo, tamponamento: o ultrassom cardíaco e pulmonar ajuda a reconhecer causas obstrutivas [SSC]

Cai na prova · sinais de sobrecarga de volume

Edema pulmonar (crepitações, piora da oxigenação) e **hepatomegalia nova ou crescente**: parar o bolus e reavaliar [SSC]. Reavaliar depois de **cada** bolus é a regra [SSC] [NICE-L].



Meningococcemia: *exantema purpúrico e hemorrágico, de bordas estreladas, que não some à pressão. Febre com exantema que não desaparece à pressão é sinal vermelho: antibiótico parenteral imediato.*

Atenção · o Plano C não serve para todo choque

Os 100 mL/kg do Plano C são para a desidratação grave da diarreia; no choque séptico, cardiogênico ou hemorrágico, o volume é titulado bolus a bolus [AIDPI] [SSC].

Capítulo III

É sepse? O escore de Phoenix

*Desde 2024, sepse pediátrica é **infecção suspeita ou confirmada com disfunção orgânica ameaçadora**, medida pelo escore de Phoenix. SIRS saiu do critério; "sepse grave" virou termo redundante [PHX].*

Tabela 3 · *Escore de sepse de Phoenix (resumo)*

Domínio	Pontos
Respiratório (0–3)	1: PaO2/FiO2 < 400 ou SpO2/FiO2 < 292 em qualquer suporte respiratório · 2: P/F 100–200 ou S/F 148–220 em ventilação invasiva · 3: P/F < 100 ou S/F < 148 em ventilação invasiva. S/F só com SpO2 ≤ 97%
Cardiovascular (0–6)	Soma de três itens, 0 a 2 cada: **vasoativo** (1 droga: 1; ≥ 2: 2) · **lactato** (5–10,9 mmol/L: 1; ≥ 11: 2) · **PAM** por idade
Coagulação (0–2)	1 ponto cada, até 2: plaquetas < 100.000/µL · RNI > 1,3 · D-dímero > 2 mg/L FEU · fibrinogênio < 100 mg/dL
Neurológico (0–2)	Glasgow ≤ 10: 1 · pupilas fixas bilateralmente: 2

Tabela 4 · *PAM (mmHg) no Phoenix*

Idade	1 ponto	2 pontos
até 1 mês	17–30	< 17
1–11 meses	25–38	< 25
1 a < 2 anos	31–43	< 31
2 a < 5 anos	32–44	< 32
5 a < 12 anos	36–48	< 36
12 a 17 anos	38–51	< 38

[PHX]. Acima da faixa de 1 ponto: 0.

Cai na prova · as duas definições

Sepse: infecção suspeita + Phoenix **≥ 2**.
Choque séptico: sepse com **≥ 1 ponto cardiovascular** [PHX].

Vale para menores de 18 anos; não se aplica à internação do nascimento nem a idade pós-concepcional < 37 semanas; idade não é corrigida para prematuridade. Pode ser calculado com as variáveis disponíveis [PHX].

Atenção · Phoenix não é triagem

O escore classifica quem **já tem** disfunção orgânica; não foi feito para reconhecer cedo. Tratar a criança com suspeita de sepse e má perfusão sem esperar fechar o escore. Os cortes de PAM classificam; **não são metas** de ressuscitação [PHX] [SSC].

Capítulo IV

O que fazer na primeira hora?

Tudo em paralelo, sem esperar confirmação microbiológica nem o Phoenix fechado. O hospital deve ter um protocolo de sepse com procedimentos padronizados [SSC].

Reconhecer	Suspeita de infecção + perfusão ruim, consciência alterada ou disfunção. Monitor, oxímetro, O2.
Acesso	Venoso periférico ou intraósseo; não atrasar nada esperando acesso central.
Lactato	Medir na avaliação inicial de toda sepse provável ou choque suspeito (recomendação forte).
Culturas	Hemoculturas antes do antibiótico, se isso não atrasar o antibiótico.
Antibiótico	**Choque séptico: até 1 h** do reconhecimento. Sepse provável sem choque: investigação rápida e, se a suspeita se mantém, antibiótico até 3 h.
Fluido	Bolus de 10–20 mL/kg, reavaliando após cada um; até 40–60 mL/kg na 1ª hora (com UTI disponível).
Vasoativo	Se a perfusão não volta: adrenalina ou noradrenalina, por veia periférica se preciso.
Foco	Drenar, desbridar, retirar cateter infectado assim que possível.

[SSC]

Exames

- **Lactato**: marcador indireto e inespecífico; elevado (≥ 2 mmol/L), mesmo abaixo do corte do Phoenix, **pode** indicar hipoperfusão. Interpretar com o exame e acompanhar a tendência [SSC].
- Plaquetas, coagulação, gasometria e Glasgow documentam os domínios do Phoenix; não é preciso painel completo para começar [PHX].
- Culturas e imagem do **foco suspeito**; pesquisa molecular de patógenos sem recomendação a favor ou contra [SSC].
- Ultrassom cardíaco e pulmonar à beira do leito, se houver treinamento, para guiar fluido e droga [SSC].

Cai na prova · os dois relógios do antibiótico

1 hora no choque séptico; idealmente **3 horas** na sepse provável sem choque, depois de investigação rápida. Os dois são da SSC 2026 [SSC].

Capítulo V

Quanto fluido e qual?

Tabela 5 · *Bolus no choque séptico conforme o lugar*

Cenário	Conduta
Com UTI disponível	Bolus de **10–20 mL/kg**, até **40–60 mL/kg na 1ª hora**, titulando pela resposta
Sistema sem UTI disponível (nem por transferência), ***sem hipotensão***	**Não** dar bolus; iniciar manutenção (recomendação forte)
Sistema sem UTI disponível, com hipotensão	Bolus de 10–20 mL/kg, até 40 mL/kg na 1ª hora
Parar quando o choque resolve ou aparece sobrecarga (crepitações, hepatomegalia)	

[SSC]. O total é teto sugerido, não meta a cumprir.

Qual solução

- **Cristaloide**, não albumina [SSC].
- Preferir **balanceado** (Ringer lactato e similares) ao SF 0,9%; SF é alternativa se não houver, e pode ser preferível na hiponatremia ou com hipertensão intracraniana [SSC].
- NICE: bolus de **10 mL/kg em menos de 10 min**, cristaloide com sódio 131–154 mmol/L, sem glicose; pedir ajuda especializada se precisar de 40–60 mL/kg ou mais [NICE-L].

AIDPI: antes de referir

Enchimento capilar > 2 s: acesso venoso e **20 mL/kg** de SF 0,9% ou Ringer lactato enquanto refere. Evitar hipoglicemia: se não engole e há acesso, flush de **5–10 mL/kg de SG 10%** e manter SG 10% [AIDPI].

Depois da ressuscitação: manutenção

- Fluido **isotônico** (sódio 131–154 mmol/L), com glicose conforme a glicemia [NICE-L].
- Holliday-Segar (fora do período neonatal): 100 mL/kg/dia nos primeiros 10 kg + 50 mL/kg/dia nos 10 kg seguintes + 20 mL/kg/dia acima de 20 kg. Recém-nascido a termo: por dia de vida, de 50–60 mL/kg/dia no 1º dia até 120–150 nos dias 5–28 [NICE-L].
- Com risco de ADH alto (doente grave), considerar **50–80%** da manutenção [NICE-L].
- Eletrólitos e glicemia ao iniciar e pelo menos a cada 24 h; contabilizar toda entrada e considerar retirar fluido na sobrecarga [NICE-L] [SSC].

Atenção · onde não há UTI, menos é mais

Onde não há terapia intensiva, a criança com sepse e sem hipotensão **não** recebe bolus: começa a manutenção. É uma das poucas recomendações fortes com certeza alta da SSC 2026 [SSC].

Capítulo VI

Quando entra o vasoativo?

- Não há volume mínimo obrigatório: é razoável iniciar **antes ou depois de 40 mL/kg**, conforme a resposta [SSC].
- **Adrenalina ou noradrenalina**: não há evidência para preferir uma como primeira linha. Na fisiologia, adrenalina quando predomina disfunção miocárdica ou baixo débito; noradrenalina quando o objetivo é subir a resistência vascular (vasodilatação) [SSC].
- Iniciar por **veia periférica** em vez de esperar o acesso central; vigiar extravasamento, mais comum nas veias distais [SSC].
- Necessidade de catecolamina em dose alta: **considerar** acrescentar vasopressina ou seguir titulando as catecolaminas (recomendação condicional) [SSC].

Tabela 6 · *Doses de partida no fluxograma brasileiro (SSC 2020)*

Droga	Dose	Quando
Adrenalina	**0,05–0,3 µg/kg/min**, IV periférica ou IO	Baixo débito
Noradrenalina	A partir de **0,05 µg/kg/min**, titulando	Hipotensão, vasodilatação

[SBP-S]. A SSC 2026 não traz doses; diluição, concentração periférica e teto: protocolo do serviço.

Outras decisões do suporte

Hidrocortisona	**Não** usar se fluido e vasoativo restabelecem a estabilidade. Insuficiência adrenal suspeita ou documentada é situação à parte [SSC]
Oxigênio	Depois da ressuscitação, alvo conservador de **SpO2 88–92%** em vez de > 94%; incerto na fase aguda e em baixo débito, anemia grave ou cardiopatia cianótica [SSC]
Intubação	Sem recomendação de intubar só por choque refratário, sem insuficiência respiratória. **Evitar etomidato** [SSC]
ScvO2	Se já há cateter central: alvo ≥ 70%; o cateter não é pré-requisito para tratar [SSC]
PAM	Sem meta universal entre os percentis 5 e 50 para a idade: individualizar pela perfusão [SSC]

Cai na prova · o que caiu em 2026

Sai a ideia de "fluido até 60 mL/kg e só depois droga"; entra vasoativo periférico precoce, sem preferência fixa entre adrenalina e noradrenalina, hidrocortisona não de rotina e oxigênio conservador após estabilizar [SSC].

Capítulo VII

Qual antibiótico e qual foco?

- Cobertura empírica **ampla** para os patógenos prováveis, considerando foco, idade, imunidade e microbiologia local [SSC].
- Imunocomprometido ou com alto risco de multirresistente: combinação empírica [SSC].
- Sem recomendação pediátrica a favor ou contra infusão estendida de betalactâmico [SSC].
- Com agente e antibiograma: **estreitar**. Sem agente identificado: estreitar ou suspender pela evolução, foco e risco, com apoio especializado. Procalcitonina não é rotina para isso onde já há programa de gerenciamento de antimicrobianos [SSC].
- Bacteremia documentada: consulta com infectologia ou microbiologia [SSC].
- **Controle do foco** assim que identificado; cateter confirmado como fonte: retirar depois de garantir outro acesso [SSC].

Tabela 7 · *Antes de referir (AIDPI, 2 meses a 5 anos)*

Fármaco	Dose
Ceftriaxona IM	**100 mg/kg/dose**, máx. **2.000 mg**, primeira dose antes da referência urgente
Penicilina G procaína IM	50.000 UI/kg, máx. 400.000 UI
Convulsão	Diazepam 0,3–0,5 mg/kg/dose IV ou retal

[AIDPI]. É dose de pré-referência, não esquema hospitalar completo.

Atenção · o esquema depende do foco

A SSC não traz esquema único para toda sepse pediátrica. Meningite, pneumonia, infecção urinária, pele, neonato e neutropenia febril têm escolhas e doses próprias: ver os cadernos de pneumonia e de antibioticoterapia e o protocolo do serviço [SSC].

Cai na prova · cultura sim, atraso não

Hemocultura antes do antibiótico **se não atrasar**. No choque séptico, a hora conta mais que a cultura [SSC].

Recuperação

A SSC 2026 acrescenta um capítulo sobre a vida depois da sepse: reabilitação precoce e individualizada e seguimento das sequelas físicas, cognitivas e emocionais [SSC].

Capítulo VIII

E se for anafilaxia?

*Reação alérgica grave, de início agudo e potencialmente fatal. Pode vir **sem pele** e sem choque. Anti-histamínico e corticoide não substituem a adrenalina [ANAF].*

Tabela 8 · *Anafilaxia é muito provável se*

1	Início agudo de pele ou mucosa (urticária, prurido, angioedema) **e** respiração comprometida, queda da PA ou disfunção de órgão, ou sintoma gastrointestinal grave
2	Hipotensão, broncoespasmo ou comprometimento laríngeo logo após alérgeno conhecido ou provável, **mesmo sem pele** (exceto sintoma respiratório inferior por aeroalérgeno comum ou alimento "inalado" sem ingestão)

Hipotensão: PAS < 70 + (2 × idade em anos) abaixo de 10 anos; < 90 mmHg acima de 10 anos; ou queda > 30% do basal

[ANAF]. Diagnóstico clínico; triptase pode ajudar depois.

Tabela 9 · *Tratamento*

Adrenalina IM	Solução 1 mg/mL (1:1.000): **0,01 mg/kg, máx. 0,3 mg** na criança (adolescente 0,2–0,5 mg), na face anterolateral da coxa; **repetir a cada 5–15 min** se preciso
Posição	Deitada, pernas elevadas; não sentar nem levantar de repente
Oxigênio	Se SatO2 ≤ 95%
Volume	SF ou Ringer: 5–10 mL/kg IV nos primeiros 5 min e 30 mL/kg na 1ª hora, regulando por pulso e PA e vigiando sobrecarga (não é teto absoluto)
Broncoespasmo	Salbutamol: 1 jato/2 kg (50 mcg/kg), máx. 10 jatos; ou nebulização 0,07–0,15 mg/kg a cada 20 min, até 3 doses, máx. 5 mg
Adrenalina IV	Diluída (1:10.000 ou 1:100.000) só na parada ou na hipotensão profunda que não respondeu ao volume e às doses IM
Segunda linha	Anti-histamínico e corticoide: pouca ou nenhuma ação na fase aguda; nunca no lugar da adrenalina

[ANAF]

Conduta · observar e dar alta

- Observar: leve, no mínimo **6–8 h**; grave, **24–48 h**. Reação bifásica em 8–12 h, em até 10% [ANAF].
- Alta: prednisona ou prednisolona 1–2 mg/kg/dia por 5–7 dias e anti-histamínico H1 de 2ª geração por pelo menos 7 dias; plano escrito; encaminhar ao alergista [ANAF].
- Autoinjetor de adrenalina, quando indicado: 0,15 mg até 30 kg; 0,3 mg acima [ANAF].

Capítulo IX

Mapa de decisão e pegadinhas

1 · Reconhecer	Perfusão ruim, consciência alterada, taquicardia, enchimento lento. Não esperar hipotensão.
2 · Tipo	Perdas? Infecção? Alérgeno? Coração (hepatomegalia, galope)? Obstrução?
3 · 1ª hora	O2, acesso periférico ou IO, lactato, hemocultura sem atrasar, antibiótico até 1 h no choque séptico.
4 · Fluido	Balanceado 10–20 mL/kg por bolus, reavaliar sempre; até 40–60 mL/kg com UTI acessível. Sistema sem UTI e sem hipotensão: sem bolus.
5 · Droga	Perfusão não volta: adrenalina ou noradrenalina periférica; dose alta: considerar vasopressina ou titular mais. Hidrocortisona não de rotina.
6 · Anafilaxia	Adrenalina IM 0,01 mg/kg (máx. 0,3 mg), repetir em 5–15 min; deitar com pernas elevadas; volume.
7 · Depois	UTI, controle do foco, descalonar, manutenção isotônica, O2 88–92% após estabilizar.

Tabela 10 · *Pegadinhas de decisão*

Afirmação tentadora	Correção
PA normal, então não está em choque	Hipotensão é tardia na criança
Precisa de Phoenix ≥ 2 para tratar	Phoenix classifica; não é triagem
Só inicio droga depois de 60 mL/kg	Pode começar antes ou depois de 40 mL/kg
Vasoativo só por acesso central	Periférico é melhor que atrasar
Hidrocortisona para todo choque séptico	Não, se estabiliza com fluido e droga
Bolus em toda sepse, em qualquer lugar	Sistema sem UTI e sem hipotensão: não
Anafilaxia sem urticária não é anafilaxia	Pode não haver pele
Anti-histamínico IV resolve a anafilaxia	Adrenalina IM primeiro; o resto é segunda linha
Etomidato para intubar no choque	Evitar etomidato na sepse

Capítulo X

Questões de estudo

1. Criança de 3 anos, febril, sonolenta, extremidades frias, enchimento capilar de 4 s, FC 170 bpm, PA normal para a idade. É correto:

A Não há choque porque a PA está normal.
B Há sinais de choque: O2, acesso, lactato, hemocultura e antibiótico em até 1 hora.
C Esperar o resultado do lactato para decidir.
D Calcular o Phoenix antes de qualquer medida.

2. Pelo critério de Phoenix, choque séptico é:

A SIRS com hipotensão.
B Infecção suspeita com Phoenix ≥ 2 e ≥ 1 ponto cardiovascular.
C Lactato acima de 2 mmol/L.
D Necessidade de 60 mL/kg de fluido.

3. Em hospital com UTI pediátrica, criança em choque séptico recebeu 20 mL/kg de cristaloide e segue mal perfundida, sem crepitações nem hepatomegalia. A melhor conduta é:

A Albumina 5%.
B Novo bolus de 10–20 mL/kg de cristaloide e reavaliar; iniciar vasoativo se não responder.
C Esperar acesso central para qualquer droga.
D Hidrocortisona de rotina.

4. Em local onde não há terapia intensiva disponível, nem por transferência, criança com sepse, perfusão razoável e sem hipotensão. Pela SSC 2026:

A Bolus de 60 mL/kg na 1ª hora.
B Não fazer bolus; iniciar manutenção e antibiótico.
C Iniciar noradrenalina.
D Intubar.

5. Menina de 6 anos, 20 kg, com sibilância, rouquidão e hipotensão minutos após comer amendoim, sem urticária. A conduta inicial é:

A Anti-histamínico IV e observar.
B Adrenalina IM 0,2 mg na coxa, deitar com pernas elevadas e volume.
C Corticoide IV e alta.
D Não é anafilaxia porque não há urticária.

6. Sobre o vasoativo na sepse pediátrica (SSC 2026), é correto:

A A dopamina é a primeira escolha.
B Pode ser iniciado por veia periférica se ainda não há acesso central.
C Só após 60 mL/kg de fluido.
D A noradrenalina é obrigatoriamente superior à adrenalina.

Gabarito comentado

1 · B. Má perfusão com PA normal é choque compensado; hipotensão é tardia. Antibiótico em até 1 h no choque séptico [SSC].

2 · B. Sepse é infecção com Phoenix ≥ 2; choque séptico, sepse com ≥ 1 ponto cardiovascular [PHX].

3 · B. Com UTI, bolus de 10–20 mL/kg até 40–60 mL/kg na 1ª hora, reavaliando; cristaloide, não albumina; vasoativo periférico se necessário [SSC].

4 · B. Em sistema sem terapia intensiva disponível e sem hipotensão, a SSC recomenda não fazer bolus (recomendação forte) [SSC].

5 · B. Hipotensão e comprometimento respiratório após alérgeno provável é anafilaxia mesmo sem pele. Adrenalina 0,01 mg/kg = 0,2 mg (máx. 0,3 mg) [ANAF].

6 · B. Sem preferência entre adrenalina e noradrenalina; periférico em vez de atrasar; sem volume mínimo obrigatório [SSC].

Apêndice

Fontes e anotações

- [SSC] WEISS, S. L. et al. Surviving Sepsis Campaign international guidelines for the management of sepsis and septic shock in children 2026. *Intensive Care Med*, v. 52, p. 937-983, 2026.
- [PHX] SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. DC de Medicina Intensiva Pediátrica. *Diretrizes para novas definições de sepse e choque séptico em pediatria: 2024 Phoenix Sepsis Score*, fev. 2024.
- [SBP-S] SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. *Novas diretrizes do Surviving Sepsis Campaign 2020 para o tratamento da sepse e choque séptico em pediatria*, fev. 2021.
- [ANAF] SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. DC de Alergia. *Anafilaxia*. Guia prático de atualização n.º 6, maio 2021.
- [AIDPI] BRASIL. Ministério da Saúde; OPAS. *Manual de quadros de procedimentos: AIDPI Criança*, 2017.
- [NICE-F] NICE. *Fever in under 5s: assessment and initial management* (NG143). [NICE-L] NICE. *Intravenous fluid therapy in children and young people in hospital* (NG29).
- [SBP-F] SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. *Manejo da febre aguda*, 2021.

Créditos das imagens

- *Типовий висип на кисті при менінгококцемії.jpg*: Глей А.І., Шкурба А.В., domínio público. Wikimedia Commons.

Anotações